

แนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity

สมาชิกทีม พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคงชีวิตไว้ได้

จากสถิติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบว่ามีผู้ป่วย 1 ราย หลังเกิดภาวะเดินหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งแพทย์มีคำสั่งการรักษา ใหยากลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine) ให้ผู้ป่วยสงบก่อนใส่ท่อช่วยหายใจ

แพทย์สั่งการรักษา Fentanyl 5 mcg v stat หลังฉีดยาโดยพยาบาลฉีด Fentanyl 5 mcg v Slowly push 2 นาที และ push ตามด้วย NSS 3 ml ตามหลักการบริหารยา HAD ผู้ป่วยมีปัญหา cardiac arrest ,CPR 3 Cycle, Naloxone 0.05mg v stat ,ROSC Admit ม10ก

จากการทำ RCA พบสาเหตุว่าเกิดจาก Chest wall Rigidity หลัง จากการใช้ยา Fentanyl 5 mcg v stat

ดังนั้นหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity โดยเฉพาะ chest wall rigidity จากการใช้ยากลุ่ม Opioids ได้แก่ Fentanyl, Morphine และ Pethidine ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐาน บริหารยาได้ถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยา พยาบาลปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีแนวทางในการบริหารยากลุ่ม Opioid ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระยะของการให้ยา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถบริหารยากลุ่ม Opioid ได้ถูกต้องถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity ให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหรือChest wall Rigidity กับผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม opioids

ผลลัพธ์สู่การเปลี่ยนแปลง



แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity

จากยากลุ่ม Opioids ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest Wall Rigidity (Fentanyl, Morphine และ Pethidine)

- แพทย์ต้องสั่งการรักษาเป็นยา drip ตัวอย่าง (Fentanyl __ mcg + 5%DW หรือ NSS Upto __ ml IV drip in 5 minutes stat) ทุกครั้ง
- ขณะแพทย์มีการใช้ยาให้เตรียมขวดยา Naloxone ไว้ซึ่งเป็น Antidote ของ Fentanyl, Morphine และ Pethidine
- ห้าม purge ยา IV analgesic/sedative drug ที่ ER โดยไม่ได้ปรึกษา staff ก่อนเด็ดขาด
- การรับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ของพยาบาล ทั้งการรับคำสั่งทางวาจากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และกรณีแพทย์เขียนคำสั่งการรักษาใน OPD Card
 - ทบทวนคำสั่งการรักษาจากแพทย์อีกครั้ง
 - ทบทวนคำสั่งการรักษาพยาบาล อีก 1 คน
 - ทบทวนคู่มือการบริหารยา HAD ของ ER เปิดอ่านทุกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนให้ยา
- ขั้นตอนการเตรียมยา เลือกขนาด Syringe ให้เหมาะสมกับขนาดยาที่แพทย์สั่งการรักษา เช่น Fentanyl 5 mcg + 5%DW หรือ NSS Upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat
 - ใช้ Syringe 1 ml ตูดยาตามที่คำนวณได้ คือ 0.1 ml
 - นำยาจาก Syringe 1 ml ใส่ Syringe 10 ml หลังจากนั้นเปลี่ยนเข็มใหม่เพื่อลด 5%DW หรือ NSS Up to 5 ml
 - นำยาใน Syringe 10 ml ต่อ Extension ยาวและใส่สาย (Extension ยาว มี Volume 1.4 ml) drip โดยใช้ Syringe Pump IV drip rate 60ml/hr
 - หลังยาใน Syringe 10 ml หมดให้ drip ต่อด้วย NSS อย่างน้อย 2 ml IV drip rate 60ml/hr เพื่อไล่น้ำยาใน Extension ยาว (Volume 1.4 ml) ให้หมด ผู้ป่วยจึงจะได้รับยาครบ
- พยาบาลทุกคนทบทวนการเตรียมยาฉีด ตัวอย่าง Fentanyl 5 mcg + 5%DW หรือ NSS Upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat ตั้งแต่การรับ Order การเตรียมยา และการ drip ยาโดยใช้ Syringe pump จนถึง การ drip NSS 2 ml ไล่น้ำยาใน Extension
- จัดทำ Video สาธิตการเตรียมยาฉีด การ drip ยา ให้พยาบาลทุกคนได้ดูและทบทวนอยู่เสมอ
- พยาบาลทบทวนการบริหารยา HAD อยู่เสมอเพื่อให้ความรู้ความชำนาญในการบริหารยา โดยเฉพาะ Fentanyl, Morphine และ Pethidine เช่น 10 minute talk

QR CODE

QR Code Video สาธิตการเตรียมยาฉีดกลุ่ม Opioids

SCAN ME

สรุปผลงานโดยย่อ

ได้พัฒนาและนำแนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและภาวะ Chest Wall Rigidity จากการใช้ยา Fentanyl, Morphine และ Pethidine มาใช้ในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยประเมินผลจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจริงด้วยวิธีการสังเกต (Observation) ขณะพยาบาลปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม 2569 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 มีผู้ป่วยที่ได้รับคำสั่งการรักษาด้วยยากลุ่ม Opioids จำนวน 17 ราย ผลการประเมินพบว่า พยาบาลสามารถบริหารยากลุ่ม Opioids ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 100 ครอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้องของยา การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ การติดตามสัญญาณชีพ และการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะแทรกซ้อน

ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยพบว่า ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยากลุ่ม Opioids และไม่พบภาวะ Chest Wall Rigidity ในผู้ป่วยทุกราย สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารยากลุ่ม Opioids ในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Video สาธิตการบริหารยา



QR Code Video สาธิตการเตรียมยาฉีดกลุ่ม Opioids